10. LE COEUR DEVELOPPEMENT DE L'ANATOMIE ARTERIELLE

DURÉE : 04:14 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge au cœur du développement embryonnaire des cellules sanguines, décrivant leur origine depuis la vésicule ombilicale jusqu'à la moelle osseuse. On explore également la persistance de l'artère mésentérique, un vestige vital de ce processus, et son rôle dans le développement intestinal. La crosse aortique est mise en avant pour illustrer le mouvement rythmique du cœur et son impact sur la circulation sanguine. En associant les dynamiques cardiaques à l'environnement fascial qui maintient les structures vitales comme l'œsophage et les bronches, la vidéo révèle comment les déséquilibres dans cette zone rythmique peuvent influencer des pathologies cardiologiques et musculosquelettiques. Une leçon essentielle pour tout thérapeute s'intéressant interconnexions corporelles.

LE CŒUR : DÉVELOPPEMENT DE L'ANATOMIE ARTÉRIELLE

ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DES CELLULES SANGUINES

Les premières **cellules sanguines** apparaissent aux environs du **18ème jour** de développement embryonnaire. Leur origine se situe en trois étapes importantes.

Initialement, elles proviennent de la **vésicule ombilicale**, où l'on trouve les **mégaloblastes primitifs**. Cette phase dure les deux premiers mois.

Dès le début du **deuxième mois**, un deuxième mouvement de production sanguine émerge à partir du **foie**.

C'est seulement aux alentours du **troisième mois** qu'une partie de cette production commence à se faire au niveau de la **moelle osseuse**.

On peut observer ici un développement de la périphérie vers le centre : d'abord la période **ombilico-pédiculaire**, puis la période **hépatique**, et enfin la moelle osseuse pour les **globules rouges**.

LE VESTIGE DU DÉVELOPPEMENT VITELLIN : L'ARTÈRE MÉSENTÉRIQUE

Le seul vestige qui va rester de ce développement vitellin est l'**artère mésentérique**.

Elle servait d'axe de rotation, un **fulcrum**, pour la rotation et le développement de l'**anse intestinale**.

Au moment où la **cavité amniotique** se forme tout autour, la vésicule vitelline, qui contient les cellules originelles pour la circulation, se réintègre.

Pour une partie, avec la vésicule vitelline, le **pédicule embryonnaire** formera le **côlon ombilical** avec le placenta. Le vestige qui va se relier est le **système mésentérique** (la vésicule supérieure). Cet axe de rotation est crucial pour le développement embryonnaire.

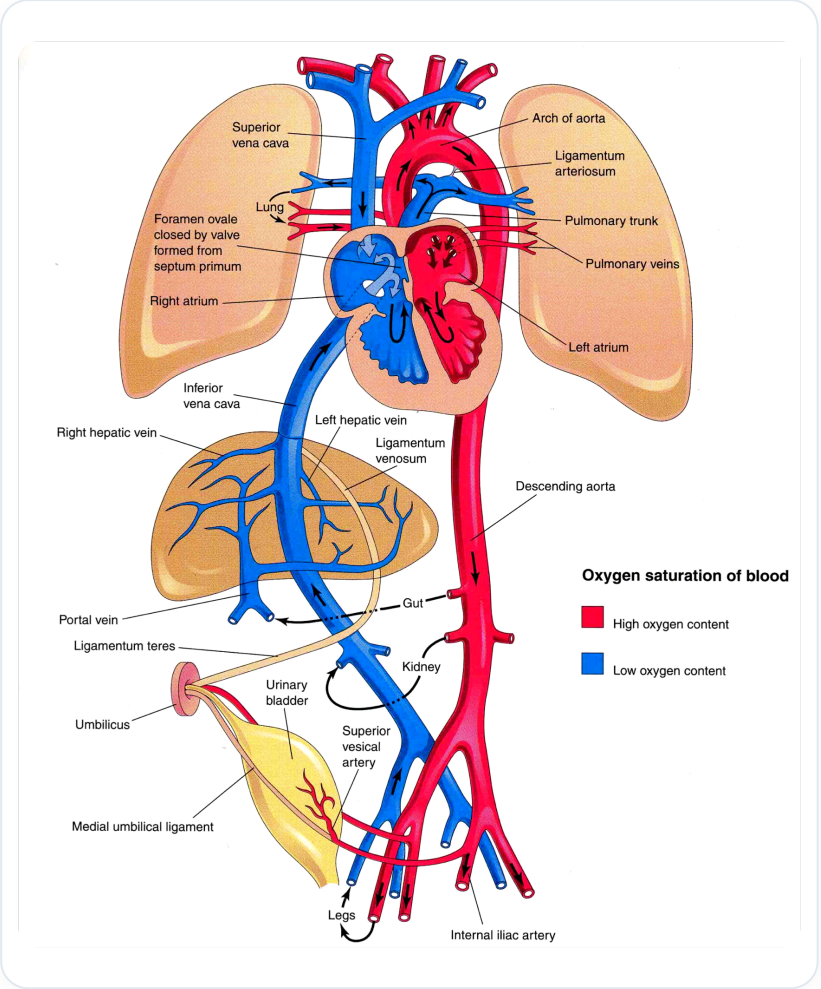


FIG. — Circulation fœtale humaine

LE MOUVEMENT DU CŒUR ET DE LA CROSSE AORTIQUE

Quand on observe le cœur, on voit la **crosse de l'aorte**. Symboliquement, on peut dire qu'elle monte ou qu'elle descend.

Ce mouvement de la crosse aortique représente le **battement du cœur**. Il reproduit presque un mouvement développemental.

La crosse de l'aorte effectue un mouvement de **torsade** ou de **détorsade** pendant le cycle cardiaque.

Au moment où le cœur pousse, la crosse de l'aorte s'ouvre pour absorber le sang. Au moment où le cœur se vide, elle se ferme en effectuant un mouvement particulier.

Elle s'ouvre pour prendre le sang et se ferme pour l'éjecter, ce qui relie intrinsèquement la crosse de l'aorte à la fonction du cœur.

LA CROSSE AORTIQUE ET LE CYCLE CARDIAQUE

C'est un peu comme un joueur de **basketball**. Au moment où le cœur monte, c'est là que l'aorte éjecte son volume sanguin.

Il faut savoir que l'aorte contient dans son volume sanguin presque autant de sang que le cœur sur le plan artériel.

Cela signifie que l'aorte participe activement à l'**éjection systolique** du sang.

Ceci est soutenu par l'**environnement fascial**, que l'on pourrait comparer à un **"fishnet stocking"** (bas résille).

LA ZONE RYTHMIQUE : UN CARREFOUR FASCIAL VITAL

La crosse de l'aorte, la **bifurcation bronchique** et l'**œsophage** sont reliés par un **fascia** commun, ce qui les maintient ensemble.

Cette zone, caractérisée par la bifurcation bronchique, est ce qu'on appelle le **point de la zone rythmique**.

Considérez les rythmes vitaux : **100 000 battements cardiaques** en 24 heures, **23 000 respirations** en 24 heures, et **1 000 à 2 000 déglutitions**.

C'est une grande zone rythmique qui se rejoint et s'attache entre **D3**, **D4** et **D5**. Ces vertèbres forment un plan d'équilibre fascial pour la zone rythmique, qui est à la fois **cardio**, **pleuro** et **digestive**.

On a l'aorte, le cœur, et en bas, une bifurcation très importante : les **artères iliaques**. En haut, il y a encore un autre niveau.

En fait, tout ceci forme un plan unitaire et pur. On constate que certaines pathologies de type **coxo-fémoral** ou autres peuvent déstabiliser le cœur. Inversement, ce qui se passe dans ces phases de rotation peut se manifester jusqu'au niveau du cœur.

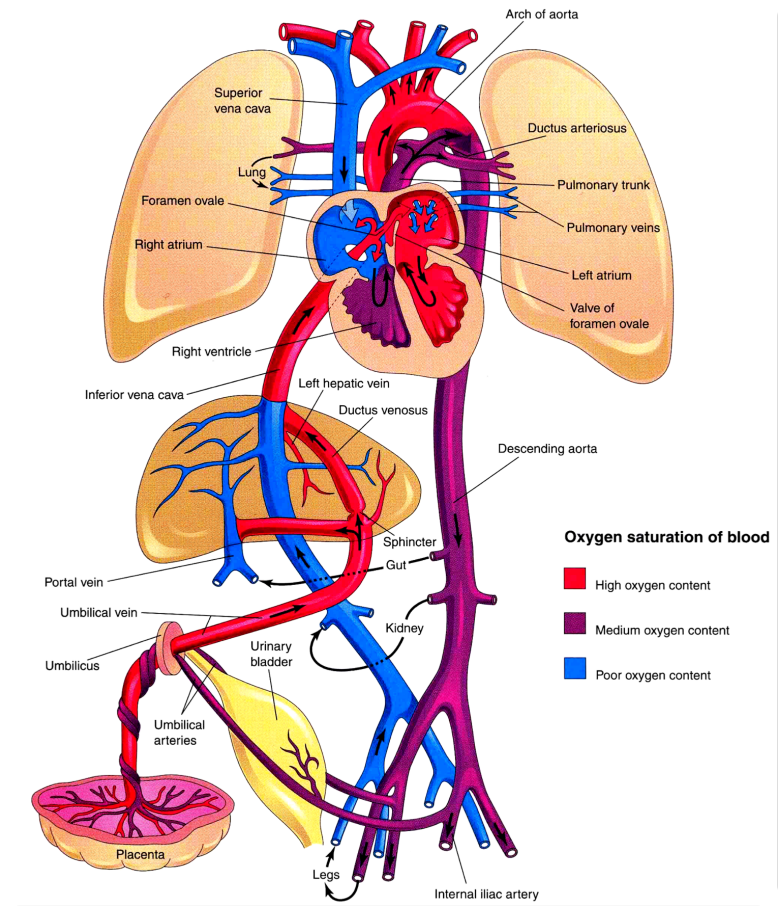


FIG. — Circulation foetale